



NOTULEN

HARI / TANGGAL : SENIN / 14 OKTOBER 2024
PUKUL : 10.00 WIB - SELESAI
JENIS MEETING : RAPAT FS IKO, KONSINYASI IMPLAN DAN RETUR OBAT
TEMPAT : KANTOR DIREKTUR RS PRIMA HUSADA

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Retur obat tertinggal Masalah : Perbedaan data antara data tagihan dengan SIMRS Keterangan : - PIC : 1. Kabid Penunjang 2. Kabid Umum 3. Kabid Keperawatan 4. Keuangan 5. Verifikator 6. Karu Irja 7. Kains Farmasi 1. Terkait masalah Retur penjualan dari PT meminta SPO dan alur lalu jika sesuai akan diterapkan kedua RS 2. Terdapat masalah perbedaan data antara data tagihan dengan SIMRS yang di tarik oleh keuangan PT dan RS. Data verifikasi penjamin SIMRS data obatnya hilang karena di lakukan retur penjualan, e-klaim dan surat tagihan di keuangan dan verif include obat karena penginputan dan surat tagihan sebelum retur penjualan dengan jarak waktu 2 minggu. 3. Verifikator ada filtrasi audit yaitu konsultasi ke dokter saja tanpa obat. Kenapa pasien ke rs tanpa tatalaksana bisa jadi audit. 4. Sudah dilakukan sounding ke DPJP namun minta fitur bahwa pasien tidak mengambil obatnya. Tindak Lanjut : 1. Draft SPO dan alur terlampir, jika acc dari PT maka akan di lakukan TTE 2. Retur penjualan obat tertinggal di sepakati Tidak dilakukan retur penjualan namun dilakukan penerimaan hibah lainnya, akan tetapi obat di apotek online harus tetap dihapus. Dengan pertimbangan ditakutkan audit dari BPJS terkait kunjungan yang tidak ada tatalaksana. Disepakati tidak mengklaim obat kronis. 3. Jika pasien tidak mengambil obat, primantara akan menghubungi pasien. jika dalam waktu 3x24 jam obat tidak diambil maka retur obat yang tidak ambil untuk pasien umum dan asuransi 2 minggu sekali, BPJS tiap tanggal 20 ke gudang farmasi. 4. Setiap bulan akan diberikan data kepada DPJP pasien-pasien yang obatnya tidak diambil. Rencananya akan diimplementasikan dalam simrs. Selama menunggu pengajuan fitur ke progamer maka mendata secara manual di spreadsheet. Sebelum dokter praktek, maka perawat mengecek dan mendata nama pasien yang terduga tidak ambil obat dan di KIE saat pasien kontrol dan di serahkan ke DPJP. Sounding ke dpjp banyak obat tertinggal maka mendata per dpjp berapa banyak pasien yang tidak mengambil obat di rapat komite medik. DPJP di harapkan melakukan KIE ke pasien yang tidak mengambil obat di bulan kemarin (melihat data yang sudah di siapkan oleh asisten/perawat), menawarkan adanya pengantaran obat.
2	Pokok Bahasan : Konsinyasi implant IKO Masalah : Lock implan di SIMRS Keterangan : -



	PIC : 1. Kabid Penunjang 2. Kabid Umum 3. Kabid Keperawatan 4. Keuangan 5. Verifikator 6. Karu IKO 7. Kains Farmasi
	1. Sistem konsinyasi harus di lock. Masalah yang paling sering yaitu Implant tidak bisa diinput untuk implant yang belum ada master barang. IKO sering minta tolong diinputkan untuk Implan baru sampai pasien pulang tidak bisa diinputkan. Alurnya sering terkendala dengan respon di keuangan PT dan pengadaan PT untuk FU ke progamer jadi prosesnya lama. Data pasien : - Abd. Manap, RM: 212670, tanggal 23/4/2024 - M. Fariz Maulana, RM: 213411, 6/5/2024 - Sumkito, RM: 146748, tanggal 17/5/2024 - Suwarno, RM: 137453, tanggal 28/5/2024 - Labib Faza Zakiyyan H., RM: 215285, tanggal 11/6/2024 - Miyatul Kusronik, RM: 216007, 29/6/2024 - Arlene Cahya Farizky, RM: 217208, tanggal 23/7/2024 - Mufidah, RM: 217414, tanggal 30/7/2024 - Ari Anto Nugroho, RM: 217626, tanggal 30/7/2024 - Muhammad Rizky Mauludi, RM: 169229, tanggal 31/7/2024 - Hermawan kristanto, RM: 217829, tanggal 3/8/2024 - Agus Widi Wikrianto, RM: 217823, tanggal 3/8/2024 - Chayun Efendi, RM : 175200, tanggal 7/8/2024 2. Butuh penyesuaian stok atau stok opname agar perawat bisa input ke pasien. Perhitungan SO implan harus segera diinput di hari yang sama. Jika diinput beda hari maka stok sudah beda.
	Tindak Lanjut : 1. Jika ada master barang implan baru akan ada pemasukan double stok namun implant harus segera diinput ke pasien, pertama dilakukan perawat input permintaan farmasi - penerimaan farmasi lain - gudang release – gudang SP – faktur datang – input faktur – release ke iko (Bermasalah: minta solusi dari PT terkait kebijakan master barang khusus implant baru). 2. Besok dilakukan stok opname pukul 13.00 bersama perawat, data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programer langsung merubah dan sistem di lock. Data barang pakai kode barang, nama barang sama jumlah. Saat stok opname tidak ada transaksi barang. Update stok dan upload kemudian progamer menginfokan ke direktur, setelah itu dilakukan lock sistem konsinyasi.
3	Pokok Bahasan : Inputan obat dan BMHP operasi
	Masalah : Masih dilakukan penulisan resep manual kemudian input ke pasien setelah operasi
	Keterangan : -
	PIC : 1. Kabid Penunjang 2. Kabid Umum 3. Kabid Keperawatan 4. Keuangan 5. Verifikator 6. Karu IKO 7. Kains Farmasi



	1. Selama operasi harus diinput dulu tapi terkendala karena IKO harus daftar pasien, daftar operasi, baru bisa input obat dan bmhp, pasien cito lebih banyak daripada pasien loadingan dan jika perawat input terlebih dahulu kemudian ambil sendiri maka bisa terjadi keliru ambil barang tidak sesuai inputan. Kendala di RS PHM seringkali jam untuk operasi adalah di mulai dari jam 05.30 (mengingat rata-rata DPJP yang ada di PHM adalah dokter RSUD) sudah operasi sedangkan shift ttk iko hanya NS (08.00-16.00). Tindak Lanjut : 1. Merubah jam kerja TTK iko mulai jam 05.00-13.00, sebisa mungkin dibuatkan 2 shift. Disepakati diinput terlebih dahulu jika tidak ada TTK maka disiapkan oleh perawat dan jika ada TTK disiapkan oleh TTK. Fitur iko minta fitur cetak resep/ nota jadi perawat tidak perlu menulis resep manual lagi. Fitur cetak nota menggunakan simrs farmasi. Kemudian farmasi menyiapkan berdasarkan inputan iko (seperti yang terjadi di depo farmasi)
4	Pokok Bahasan : Inputan kelas di SIMRS Masalah : Inputan salah kelas di SIMRS Keterangan : - PIC : 1. Kabid Penunjang 2. Kabid Umum 3. Kabid Keperawatan 4. Keuangan 5. Verifikator 6. Karu IKO 1. Jika ada inputan salah kelas, kasir selalu terburu-buru input dan telpon ke iko untuk revisi kelas. Dari awal IKO tidak bisa merubah hak kelas, saat awal masuk operasi di input kelas 2 namun saat pasien pulang kelas di kasir muncul kelas 3 sedangkan iko sudah terinput kelas 2, iko tidak bisa merubah inputan kelas 3. Yang mendaftarkan adalah pendaftaran. Kasir tidak boleh dikasih akses untuk merubah inputan. Saran Iko harus mengecek general concern terlebih dahulu sebelum input namun iko tidak nutut karena masih crowdit operasi jadi kasir harus menunggu iko mengedit hak kelas. 2. Di IKO terdapat perawat sebanyak 7 orang yang khusus bedah. Di phm penjadwalan untuk asisten dokter di sama ratakan sehingga kebanyakan on call. Asisten Bedah syaraf yang sudah pelatihan instrument yaitu perawat atas nama Eko. Asisten Bedah syaraf harus laki-laki karena operasi bisa sampai 6 jam. Tindak Lanjut : 1. Pengumpulan kwitansi operasi tiap akhir shift, inputan ke pasien setiap selesai operasi. Dibuatkan spreadsheet satuan kerja yang bisa akses iko. Di SIMRS biaya mengikuti kelas yang ditempati. 2. Pelatihan bedah syaraf per 2 minggu. Jika 2 minggu tidak cukup maka dari RS diajukan 1 bulan. Mohon SDM melakukan evaluasi kurikulumnya selama 2 minggu yang di dapat apa saja jika ada yang berbeda maka diajukan lagi.

Pemimpin Rapat
PLT Direktrur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Malang, 14 Oktober 2024
Notulis

Dokumen ditandatangani secara
elektronik. Gunakan Pembaca
Tandatangan Elektronik Untuk
Verifikasi Dokumen Ini

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm



DOKUMENTASI

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	RETUR OBAT RAWAT JALAN YANG TINGGAL OLEH PASIEN		
	No. Dokumen	No. Revisi 05	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 14 Oktober 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Penanganan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada terhadap retur obat rawat jalan yang ditinggal pasien tanpa alasan yang jelas dengan batas waktu 2x24 jam.		
Tujuan	1. Sebagai acuan retur obat rawat jalan yang ditinggal oleh pasien tanpa alasan yang jelas dengan batas waktu 2x24 jam. 2. Meminimalisir terjadinya selisih stok		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 266/I-PDM/IFRS/III/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi.		
Prosedur	Depo Farmasi : 1. Panggil nama pasien hingga 3 kali pemanggilan pada saat akan menyerahkan obat sesuai dengan urutan antrian dalam SIMRS. " Atas nama Bapak/Ibu .. (sebut nama pasien)" 2. Pasien yang tidak mengambil obat setelah dipanggil, simpan obat atas nama pasien tersebut dalam keranjang obat tertinggal dalam waktu yang sudah di sepakati. 3. Klik kanan obat selesai di SIMRS. 4. Kumpulkan resep dan obat yang tidak diambil pasien. 5. Lakukan hapus tagihan obat kronis di apotek online BPJS Kesehatan. 6. Serahkan obat tertinggal ke gudang farmasi setiap tanggal 20. Gudang Farmasi 1. Lakukan input "penerimaan hibah lainnya" sesuai resep dan obat yang di retur. 2. Rekap obat yang di retur kemudian menginfokan ke depo farmasi untuk input minta barang unit ke Gudang retur. 3. Release stok ke Depo farmasi.		
Unit Terkait	1. Depo Farmasi Rawat Inap 2. Depo Farmasi Rawat Jalan		



 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERMINTAAN BARANG KONSINYASI (IMPLANT)		
	No. Dokumen	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 14 Oktober 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Proses kegiatan permintaan barang konsinyasi (implant) dari Instalasi Kamar Operasi kepada Gudang Farmasi sebelum dilakukan tindakan pembedahan pada pasien		
Tujuan	1. Sebagai acuan dalam melakukan permintaan barang konsinyasi 2. Tercapainya pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara aman dan benar		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 266/I-PDM/IFRS/III/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi.		
Prosedur	1. Lakukan stok opname konsinyasi implant oleh gudang farmasi, perawat dan progamer. 2. Terima informasi dari perawat IKO terkait permintaan implant yang diminta. 3. Siapkan implant sesuai dengan permintaan IKO. 4. Lakukan serah terima dengan perawat IKO menggunakan buku serah terima. 5. Lakukan permintaan "farmasi" sesuai LPO ke Gudang farmasi oleh karu IKO. 6. Lakukan penerimaan LPO (Lembar Pemakaian Operasi) dengan perawat IKO maksimal 1x24 jam setelah pengambilan barang/ setelah operasi. 7. Lakukan cek kesesuaian antara LPO dengan inputan implant pada SIMRS. 8. Lakukan SP kepada Pengadaan setelah LPO diterima dan sesuai, permintaan bisa dilakukan setiap hari. 9. Terima faktur dan implant dari distributor, 10. Lakukan input "penerimaan barang farmasi" kemudian release stok ke IKO sesuai poin 6. 11. Lakukan sterilisasi alat yang akan digunakan di CSSD. 12. Terima informasi dari CSSD jika alat sudah steril dan siap diambil. 13. Ambil implant steril di CSSD dan lakukan serah terima.		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2. Instalasi Kamar Operasi 3. CSSD		



 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERMINTAAN BARANG KONSINYASI (IMPLANT) BARU		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 14 Oktober 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Proses kegiatan permintaan barang konsinyasi (implant) baru dari Instalasi Kamar Operasi kepada Gudang Farmasi sebelum dilakukan tindakan pembedahan pada pasien. Master barang implan belum tersedia di SIMRS.		
Tujuan	1. Sebagai acuan dalam melakukan permintaan barang konsinyasi baru 2. Tercapainya pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara aman dan benar		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 266/I-PDM/IFRS/III/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi.		
Prosedur	1. Terima informasi dari perawat IKO terkait permintaan implant yang diminta. 2. Siapkan implant sesuai dengan permintaan IKO. 3. Lakukan serah terima dengan perawat IKO menggunakan buku serah terima. 4. Lakukan permintaan "farmasi" sesuai LPO ke Gudang farmasi oleh karu IKO. 5. Lakukan penerimaan LPO (Lembar Pemakaian Operasi) dengan perawat IKO maksimal 1x24 jam setelah pengambilan barang/ setelah operasi. 6. Lakukan input "penerimaan farmasi lain" sesuai LPO. 7. Lakukan release stok ke IKO. 8. Lakukan cek kesesuaian antara LPO dengan inputan implant pada SIMRS. 9. Lakukan SP kepada Pengadaan setelah LPO diterima dan sesuai, permintaan bisa dilakukan setiap hari. 10. Terima faktur dan implant dari distributor, 11. Lakukan input "penerimaan barang farmasi" kemudian release stok ke IKO. 12. Lakukan sterilisasi alat yang akan digunakan di CSSD. 13. Terima informasi dari CSSD jika alat sudah steril dan siap diambil. 14. Ambil implant steril di CSSD dan lakukan serah terima.		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2. Instalasi Kamar Operasi 3. CSSD		